

5- Le Systeme Circulatoire Mise à Jour

Donc le développement des trajectoires vasculaires. Première chose, l'image qu'on a spécifiquement du système circulatoire, tu as un système qui part du cœur, qu'on appelle le système artériel, et puis on te dit, ça revient au cœur par le système veineux. Je suis d'accord que ça part et que ça revient. Il y a en fait trois systèmes veineux différents. Un système comme ceci, un système qui est uniquement en relation avec le système, on va dire, vertébral. Et troisièmement, il y a un système portal. Ça, ça va drainer tout le système ectodermique. Ça, ça va drainer tout le système mésodermique. Ça, ça va drainer tout le système endodermique. Tu vois, effectivement, ça vient ici. Mais ça peut faire demi-tour. Ça peut prendre d'autres trajectoires en fonction des pressions et des dépressions dans le cœur. Tu vois, tout d'un coup, quelqu'un qui a un système portal trop chargé, s'il ne sait pas faire son retour, il va prendre une autre voie. Il va prendre un système cavale de retour avec des champs très spécifiques qui sont les zones diaphragmatiques d'échange. Donc ça veut dire que les pressions peuvent se faire. Donc non seulement ça ne fait pas un tour comme ceci, mais ça fait ceci et ça peut reprendre d'autres voies. Il y a comme une intelligence dans ce système pour aller vers la maison du cœur. Ça part bien du cœur, ça revient bien au cœur. Mais dans ton système veineux, le système circulatoire, la vision qu'on en a, date du XVIIe siècle. Ça veut dire que maintenant, elle est rénovée. Et les premiers qui ont commencé à étudier ça, c'est M. Herveillat. C'est M. Batson. Et que ce n'est pas le même retour. Ma réaction, c'était « Oui, mais moi, on m'a expliqué que dans les veines, il y avait des valves qui empêchaient le retour. » Eh bien, en fait, c'est juste dans les grosses veines, mais pas du tout dans tout le réseau. Il y a très peu, en fait, de petites valves comme ça. Parce qu'on va étudier les veines cardinales, qui vont devenir subcardinales et supracardinales. Vous avez un autre système qu'on appelle le système vitellin, en rapport avec le foie. Et puis, un troisième niveau, ce sera tout le système ombilical. Ce sera

tout le développement du système veineux, qu'on va réétudier dans le système vertébral-caval-portal, et qu'on va remettre dans la pratique ostéopathique. Tout le système cardinal va tellement se modifier, qu'on verra ça en détail, pour former des tissus, des structures qui vont s'intégrer à la fois dans les structures ectodermiques et mésodermiques. J'ai trouvé une méthode où vous pouvez mettre ça dans la pratique. Je résume ça, finalement. Mais il faut avoir compris le sens. Les stases, les changements de pression abdominale, etc. Comme quelqu'un qui vient avec des lombalgies, ça peut être une surcharge du système portal, en fait. Et donc, il faut redégager le système vertébral par surcharge portale. Et c'est là où vous avez tout le mécanisme des discopathies qui va s'intégrer. Tout ce qui est stase va amener une acidité, locale même, qu'il faudra pouvoir redégager. On constate que ça va être toujours utilisé un même schéma. Que quand j'ai une tumeur de mon sacrum, j'ai presque toujours, au niveau métastase, rein gauche, poumon gauche et cerveau. Mais on constate qu'il y a toujours une même ligne. Ça veut dire que dans les problèmes de prostate, ça peut se retrouver ici. De plus, il y a une continuité vasculaire entre les sinus vertébraux et les sinus sacrés du petit bassin. Une prise de sang faite dans un bras ici. Ne prend pas la totalité d'une prise de sang qui serait prise dans un système veineux, artériel ou autre.